TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 3 Suy dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng trẻ em

Tóm tắt từ tài liệu Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf (25 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ
2. NGUYÊN NHÂN
3. PHÂN LOẠI THEO WHO (TRẺ 0–5 TUỔI)
4. SINH LÝ BỆNH
5. LÂM SÀNG
6. XÉT NGHIỆM VÀ BIẾN CHỨNG
7. ĐIỀU TRỊ SUY DINH DƯỠNG CẤP NẶNG
8. ĐIỀU TRỊ SUY DINH DƯỠNG NHẸ VỪA VÀ PHÒNG NGỪA

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ

- **Suy dinh dưỡng:** hậu quả sinh hóa và/hoặc thể chất của **nhập dưỡng chất không đầy đủ lâu dài**; phát hiện qua thiếu cân theo tuổi hoặc theo chiều cao. Chỉ số nhân trắc **dưới −2 SD** là thiếu dinh dưỡng mức trung bình và nặng.
- **Suy dinh dưỡng protein – năng lượng (PEM):** do thiếu đạm và năng lượng ở nhiều mức độ.
- **Suy dinh dưỡng bào thai:** chậm tăng trưởng trong tử cung (**IUGR**) hoặc nhẹ cân so với tuổi thai (**SGA**).
- WHO: khoảng **500 triệu** trẻ thiếu dinh dưỡng ở nước đang phát triển; suy dinh dưỡng là **nguyên nhân hàng đầu** gây tử vong trẻ < 5 tuổi.
- Việt Nam: > 50% (thập niên 1980) → 17,5% (2010), giảm khoảng **2% mỗi năm**. Năm 2010: nhẹ cân 17,5%, **thấp còi 29,3%**, gầy còm 7,1%.

2. NGUYÊN NHÂN

2.1. Ba nguyên nhân thường gặp ở trẻ Việt Nam

- **Nhiễm trùng** kéo dài, tái phát (lao, HIV), liên quan môi trường kém vệ sinh, nghèo.
- **Dị tật bẩm sinh:** sứt môi, chẻ vòm, hẹp môn vị; tim bẩm sinh; tật đầu nhỏ, não úng thủy, bại não; hội chứng Down.
- **Mẹ thiếu kiến thức nuôi dưỡng** (nguyên nhân chiếm đa số): không cho bú mẹ, ăn dặm sai (quá sớm, thiếu đạm và béo), **kiêng ăn khi bệnh** (tiêu chảy, viêm phổi).

2.2. Các cách phân nhóm nguyên nhân

- **Nguyên phát:** nhập thực phẩm thiếu do kinh tế – xã hội. **Thứ phát:** tăng nhu cầu (nhiễm trùng, chấn thương, ung thư), tăng mất (kém hấp thu), bệnh tiêu hóa.
- **Cơ năng** (tâm lý, xã hội, hành vi) và **thực thể** (bệnh cấp, mạn), có thể cùng tồn tại.
- **Sai lầm nuôi dưỡng:** mẹ mang thai ăn quá ít; không cho bú sữa non, cho trẻ < 6 tháng ăn ngoài sữa mẹ; ăn dặm quá sớm hoặc quá trễ; không biết nuôi trẻ khi tiêu chảy, sốt; vệ sinh kém.

3. PHÂN LOẠI THEO WHO (TRẺ 0–5 TUỔI)

Tình trạng	Tiêu chuẩn
Béo	WH hoặc BMI theo tuổi **> 3 SD**
Thừa cân	WH hoặc BMI theo tuổi > 2 SD và ≤ 3 SD

Tình trạng	Tiêu chuẩn
Nhẹ cân trung bình / nặng	WA < −2 SD và ≥ −3 SD / WA **< −3 SD**
Suy dinh dưỡng cấp trung bình (MAM)	WH ≤ −2 SD và ≥ −3 SD, hoặc **MUAC 115 – < 125 mm**
Suy dinh dưỡng cấp nặng (SAM)	WH **< −3 SD**, hoặc **MUAC < 115 mm**, hoặc **phù ấn lõm**
Suy dinh dưỡng mạn (thấp còi) trung bình / nặng	HA ≤ −2 SD và ≥ −3 SD / HA < −3 SD

- WA: cân theo tuổi; HA: cao theo tuổi (phản ánh **mạn tính**); WH: cân theo cao (phản ánh **cấp tính**).
- Trẻ 5–18 tuổi dùng **BMI theo tuổi**; người lớn dùng BMI (nặng < 16).

4. SINH LÝ BỆNH

- **Vòng xoắn suy dinh dưỡng – nhiễm trùng:** suy dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng → dễ nhiễm trùng; nhiễm trùng tăng nhu cầu, gây chán ăn → suy dinh dưỡng nặng hơn.
- **Kwashiorkor (thể phù):** khi đói cơ thể dùng mỡ rồi đạm; nhập quá nhiều carbohydrate làm tăng huy động đạm → **giảm tổng hợp albumin** → phù; giảm apolipoprotein → **gan nhiễm mỡ**. Góp phần: aflatoxin, gốc tự do (giảm glutathione).
- **Hội chứng nuôi ăn lại:** bồi hoàn dinh dưỡng nhanh làm đường vào tế bào kéo theo điện giải → **giảm phospho** (quan trọng nhất), **kali, magne** → biến chứng tim, phổi, thần kinh. Nguy cơ cao ở **tuần đầu** điều trị. Phòng ngừa: **ăn lại chậm**, theo dõi và bù điện giải sớm.

5. LÂM SÀNG

5.1. Suy dinh dưỡng bào thai (IUGR)

- Trẻ đủ tháng cân nặng **≤ 2.500 g**, hoặc trẻ sinh non có cân nặng **dưới bách phân vị 10**.
- Biến chứng: suy hô hấp, xuất huyết não thất, nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử; lâu dài chậm lớn, di chứng thần kinh.
- Nguyên nhân: **thai** (rối loạn nhiễm sắc thể, nhiễm trùng bào thai CMV, rubella, giang mai), **nhau** (nhau nhỏ, nhồi máu, tách nhau), **mẹ** (nhiễm độc thai, tăng huyết áp, thiếu oxy, suy dinh dưỡng, thuốc lá).

5.2. Suy dinh dưỡng nhẹ và vừa

- **Thường gặp nhất**, triệu chứng nghèo nàn: đứng cân hoặc sụt cân, mất vẻ bụ bẫm, giảm lớp mỡ dưới da, bắp thịt nhão, chậm phát triển vận động.

5.3. Suy dinh dưỡng cấp nặng

- Trẻ li bì, thờ ơ, quấy khóc; **chán ăn là dấu hiệu báo biến chứng**.
- **Thể teo (marasmus):** thường sau cai sữa, ăn dặm sai, tiêu chảy. Sụt cân, **mất lớp mỡ dưới da** (da nhăn, gò má lõm, **mặt khỉ**), teo cơ, **không phù**, mạch chậm, hạ thân nhiệt.
- **Thể phù (kwashiorkor): thiếu đạm** trong khi năng lượng tương đối đủ (ăn cháo, bột toàn tinh bột, không bú mẹ). **Phù ấn lõm bắt đầu ở mu bàn chân** rồi lan lên; độ 1 (bàn chân), độ 2 (thêm cẳng chân, tay), độ 3 (toàn thân, cả mặt). **Gan to**, da tăng sắc tố, **tróc da như tróc sơn**, tóc thưa màu nâu đỏ dễ rụng, **mặt tròn (moon face)**, sưng tuyến mang tai.
- **Thể hỗn hợp:** thể phù đã được điều trị.
- Dấu hiệu khác: chấm **Bitot**, khô mắt (thiếu vitamin A); chảy máu nướu (vitamin C); **men răng rỗ, chậm mọc răng**; dấu **Chvostek, Trousseau** (hạ calci).
- IMCI 2014: đánh giá bằng **phù hai mu chân**, không thèm ăn, cân theo cao thấp, vòng cánh tay thấp, **lòng bàn tay nhợt**.

6. XÉT NGHIỆM VÀ BIÊN CHỨNG

- Nhẹ – vừa: tìm thiếu vi chất theo hướng lâm sàng (sắt, kẽm, calci, vitamin D).
- Nặng: công thức máu, **đường máu**, điện giải (Na, K, toan kiềm), đạm, albumin, prealbumin, creatinine, CRP, ký sinh trùng sốt rét, xét nghiệm phân.
- **Biến chứng gần:** tử vong (suy dinh dưỡng giải thích **35%** tử vong trẻ < 5 tuổi), nhiễm trùng (nhiễm trùng huyết, viêm phổi), **hạ đường huyết**, **hạ thân nhiệt**, suy tim, **thiếu vi chất (vitamin A, sắt, kẽm thường gặp nhất)**.
- **Biến chứng xa:** lùn, chậm phát triển tâm vận, giảm học tập và lao động; tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường, tim mạch; mẹ suy dinh dưỡng sinh con nhẹ cân.

7. ĐIỀU TRỊ SUY DINH DƯỠNG CẤP NẶNG

- **Chẩn đoán SAM:** một trong ba dấu hiệu: **WH < −3 SD**, **MUAC < 115 mm**, **phù hai bàn chân**.
- **Có biến chứng** (chán ăn hoặc bất kỳ biến chứng nào) → **điều trị nội trú**; **không biến chứng** (còn thèm ăn) → **ngoại trú**; suy dinh dưỡng cấp vừa → tại nhà.
- Đánh giá ban đầu: dấu hiệu nguy hiểm (không uống được, ói tất cả, li bì, co giật), sốc, mất nước, thiếu vitamin A ở mắt (**khám mắt rất nhẹ nhàng**), **test thèm ăn** bằng thức ăn điều trị sẵn dùng (**RUTF**).

7.1. Mười bước điều trị (ổn định ngày 1–7, hồi phục tuần 2–6)

- **Bước 1 – Hạ đường huyết:** đường máu **< 3 mmol/L (54 mg/dL)**; không đo được thì **xem như có hạ đường huyết**. Cho **50 mL glucose 10%** uống hoặc qua sonde, rồi ăn **F-75** mỗi 2 giờ; trẻ không tỉnh: glucose 10% **5 mL/kg** tĩnh mạch.
- **Bước 2 – Hạ thân nhiệt:** nách **< 35°C** hoặc hậu môn **< 35,5°C**. Cho ăn ngay, ủ ấm (che đầu, da kề da), tránh gió lùa, dùng kháng sinh.
- **Bước 3 – Mất nước: không truyền tĩnh mạch trừ khi sốc**. Bù chậm bằng **ReSoMal** (natri **37,5 mmol/L**, thay cho ORS WHO natri 75 mmol/L): **5 mL/kg mỗi 30 phút trong 2 giờ đầu**, sau đó 5–10 mL/kg/giờ. Sốc: Ringer lactate – Dextrose 5%.
- **Bước 4 – Điện giải: không dùng lợi tiểu điều trị phù**; cơ thể thừa natri dù natri máu thấp. Thêm **kali 3–4 mmol/kg/ngày**, **magne 0,4–0,6 mmol/kg/ngày**; thức ăn không thêm muối.
- **Bước 5 – Nhiễm trùng:** xem như **mọi trẻ SAM đều nhiễm trùng**, cho kháng sinh phổ rộng ngay. Không biến chứng: **amoxicillin uống**; có biến chứng: ampicillin hoặc penicillin tĩnh mạch + **gentamicin**. Tiêm **vaccin sởi** nếu ≥ 6 tháng chưa chủng.
- **Bước 6 – Vi chất: chưa cho sắt ngay** dù thiếu máu; chờ trẻ thèm ăn, tăng cân (thường tuần 2), bắt đầu sắt **3 mg/kg/ngày** sau 2 ngày dùng F-100. Vitamin A liều cao chỉ khi có dấu hiệu mắt hoặc sởi: **50.000 U (< 6 tháng), 100.000 U (6–12 tháng), 200.000 U (> 12 tháng)**. Acid folic, kẽm 2 mg/kg/ngày, đồng.
- **Bước 7 – Bắt đầu ăn lại:** bữa nhỏ mỗi 2–3 giờ, ít lactose, áp lực thẩm thấu thấp; **năng lượng 100 kcal/kg/ngày**, **đạm 1–1,5 g/kg/ngày**, nước **130 mL/kg/ngày** (100 mL/kg nếu phù nhiều). Ăn qua sonde nếu ăn ≤ 80% hai bữa liền.

Ngày	Tần số	mL/kg/cữ	mL/kg/ngày
1–2	2 giờ	11	130
3–5	3 giờ	16	130
≥ 6	4 giờ	22	130

- **Bước 8 – Nuôi ăn bắt kịp:** khi **thèm ăn trở lại và tăng cân**, chủ yếu ngoại trú.

- **Bước 9 – Kích thích cảm giác:** chăm sóc yêu thương, chơi có kế hoạch **15–30 phút/ngày**, tiếp xúc với mẹ nhiều.
- **Bước 10 – Chuẩn bị tái khám:** theo dõi đến khi **cân theo cao đạt 90% (−1 SD)**; tái khám tuần 1, 2, 4 rồi hằng tháng đến 6 tháng; tiêm chủng đủ, vitamin A mỗi 6 tháng.

8. ĐIỀU TRỊ SUY DINH DƯỠNG NHẸ VỪA VÀ PHÒNG NGỪA

- **Nguyên tắc:** giáo dục dinh dưỡng theo tuổi; kết hợp **chủng ngừa, xổ giun, uống vitamin A**; chăm sóc bằng tình thương.
- **Viện Dinh dưỡng:** bú mẹ theo nhu cầu cả ban đêm; trẻ > 6 tháng ăn bổ sung **tăng số bữa**, nấu kỹ ăn ngay; tăng đậm độ năng lượng bằng **men tiêu hóa từ giá đậu xanh** (10 g giá cho 10 g bột), thêm **dầu mỡ**, thịt, cá, trứng, sữa giàu năng lượng.
- **Phòng ngừa: bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu**, ăn dặm đúng lúc (6 tháng) và đầy đủ, **rửa tay với xà phòng**, bổ sung vitamin A, sắt; xổ giun; phòng sốt rét; bù nước khi tiêu chảy; thực phẩm tăng cường iod, sắt, vitamin A, kẽm.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf khi cần chi tiết.